جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هند سيد عبدالعزيز محمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزيتون **العنوان :** القاهرة حلوان
رقم البطاقة : 28209270102087 **رقم التليفون :** 01141411874 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 19-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-09-1982 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هند سيد عبدالعزيز محمد
National ID: 28209270102087



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

كود المستشفى: **102233**

وزارة الصحة و السكان
الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٠٧٠٨٧١٦

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض هند سيد عبدالعزيز محمد الرقم القومي ٢٨٢٠٩٢٧٠١٠٢٠٨٧
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٣٨٦٢١١٦٦ بتاريخ ٢٠٢٦-٠٢-٢٢ بمبلغ ٣٠٠٠ مدة القرار ٩٠ يوم
تاريخ الفاتورة ٢٠٢٦-٠٤-٠٤ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء علاج تدعيمي وتلطيفي ودوائي وابحاث الخصم (%) ٠

مـدين	بيـــــــان	كميـــــــة	وحـــــــدة	تاريخ الصـــــرف	ملاحظـــــــات
٣٢.١٠	Calcium Carbonate 500mg	30	capsule	04/04/2026	
٦٥.٥٠	methylcobalamin 1000mg	30	patch	04/04/2026	
١٠٦.٨٠	gabapentin 300mg	30	capsule	04/04/2026	
٢٢.٢٥	Normal Saline 0.9 % Solution	1	Bottle 500 ml WITH rubber cap	19/06/2026	ER
٤٠.٥٠	Pantoprazole 40mg	1	ampoule	19/06/2026	ER
١٨	Tiemonium 5 mg / 2 ml	1	ampoule	19/06/2026	ER
٨	ondasetron 4mg	1	ampoule	19/06/2026	ER
١٠٣	Dexamethasone sod. PO4 8mg	1	AMP / 2 ML	19/06/2026	ER
٤.٤٩	Chlorpheniramine 5mg Injection	1	ampoule	21/06/2026	

٢٥	NORMAL SALINE 0.9% 100ml	1	bottel	21/06/2026	
٥.٦٢	Dexamethasone sod. PO4 8mg	1	AMP / 2 ML	21/06/2026	
٢٥	NORMAL SALINE 0.9% 50ml	1	bottel	21/06/2026	
١١٠	بوتاسيوم	1		19/06/2026	ER
١١٠	صوديوم	1		19/06/2026	ER
٧٠	كرياتنين	1		19/06/2026	ER
٧٠	بولينا	1		19/06/2026	ER
٣٥٠	غازات بالدم	1		19/06/2026	ER
١٥٠	صورة دم كاملة	1		19/06/2026	ER
١٥٠	صورة دم كاملة	1		21/06/2026	
٧٠	كرياتنين	1		21/06/2026	
١٦٠	كالسيوم متاين	1		21/06/2026	
١٦٩٦.٢٦	الاجمالـــــــــي				

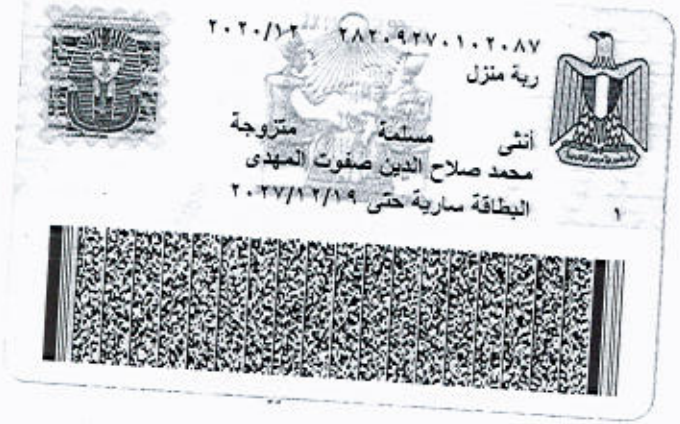
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص — المراجع — رئيس حسابات المرضى — مدير الشئون المالية

نرمين رمضان — محمد كيلاني — ندى حسن

جوستاف روسي - مصر





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / هند سيد عبد العزيز محمد	Request No.	: 13009837
Patient No.	: 28209270102087	Request Date	: 30/12/2024
Path No.	: 5251/24	Verification Date	: 28/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Left breast malignant looking mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- Ki67: Positive in 17% of tumor cells.
- SISH: Amplified.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr.Amal Hareedy.
Dr.Rana Fathy.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: هند سيد عبدالعزيز محمد	
MR. : 1945	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has metastatic breast cancer with bone involvement and is receiving HERCEPTIN IV and ZOMETA in addition to FEMARA; an echocardiogram performed on 3/2 showed an ejection fraction of 64%, and a new CT scan of the chest, abdomen, and pelvis was pending.

The patient continued on FEMARA alone on the day of assessment, with HERCEPTIN IV and a repeat echocardiogram scheduled; a new CT scan of the chest, abdomen, and pelvis was still pending.

The patient received HERCEPTIN IV, FEMARA, and ZOLADEX today, with the next ZOLADEX dose planned for 16-08; an echocardiogram will be performed at the next visit.

Clinical pharmacy intervention documented that the patient had received HERCEPTIN and FEMARA the previous week and received ZOMETA today.

A new echocardiogram was requested, and a bone scan was ordered; the patient continues on HERCEPTIN IV and FEMARA.

The patient with metastatic breast cancer to bone is on paracetamol 1000 mg every 6 hours, and tramadol 50 mg every 12 hours was added for pain control.

The patient remains on FEMARA and HERCEPTIN for metastatic breast cancer to bone; the most recent bone scan compared with April 2026 shows stable disease, and the CT CAP was free of progression, allowing continuation of the current treatment regimen.

تحريرا في ,

التاريخ :	18-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / هند سيد عبد العزيز محمد	Request No.	: 13009837
Patient No.	: 28209270102087	Request Date	: 30/12/2024
Path No.	: 5251/24	Verification Date	: 28/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast malignant looking mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 29/12/2024.

Gross Examination:
Four grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2,SISH, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Undetected.
* Perineural invasion: Undetected.
* Angioinvasion: Undetected.
* Microcalcifications: Undetected.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
- Ki67: 17% nuclear reaction of tumor cells.
- SISH: Amplified.
(Average Her2 copy No. (6.2), Her2/CEP17 ratio: (3.3))
Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.

Diagnosis:

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / هند سيد عبد العزيز محمد	Request No.	: 13009837
Patient No.	: 28209270102087	Request Date	: 30/12/2024
Path No.	: 5251/24	Verification Date	: 28/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Dr.Samia Ali.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Mrs. HEND SAED ABDELAZIZ
Date: 10-12-2025

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: left breast cancer, underwent NACT , follow ups study.

Findings:

Right breast.

- Heterogenously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses asymmetry suspicious microcalcifications.
- UOQ focal asymmetry , likely at site of previous surgical drainage
- Benign calcifications
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Heterogenously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- UIQ ill-defined spiculated mass lesion.
- Evidence of benign macrocalcification.
- **Ultrasound** demonstrated scattered simple cysts.
- 11-12 o'clock, zone b, 9 mm from skin, ill- defined hypoechoic spiculated mass lesion, measures 15 x 10 mm, with peripheral color uptake on doppler study.
- 12 o'clock, zone a small hypoechoic circumscribed nodule, measures 6 x 3 mm, with no color uptake on doppler study.
- A small 11 o'clock, zone a, rounded lesion measures 3 x 2 mm, with slight echogenic contents, likely complicated cyst
- Normal skin/nipple/areola complex.
  -No pathological axillary, infra or supra clavicular lymph nodes.

Conclusion: -

Right breast (BIRADS 2): Bening macrocalcifications, post-surgical drainage sequalae
Left breast (BIRADS 6): 11-12 o'clock suspicious mass lesion, with 12 o'clock indeterminate nodule and 11 o'clock? complicated cyst.

Best Regards,
DR, RANIA AHMED, MD

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	

Mammogram
[DOCTYPE:MAMMOGRAM]

PATIENT NAME: HEND SAYED ABDEL AZIZ MOHAMMED
GENDER: Female
DATE : 15-Apr-2026 11:49 AM

PATIENT ID: 10125259772
AGE: 43 y
ORDER: 3829337

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:
Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report: Compared to previous bone scan dated2/3/2025, the current study revealed :-
More sclerosis of the still seen suspicious DV10 lesion.
Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.
Arthritic changes are seen over both knees.
Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

More or less stationary course of the DV10 lesion.

Reported By,

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant **15-Apr-2026 12:31 PM**

www.Baheya.org 16602
BoneScan
COPYRIGHT SCAN

جوستاف روسي

Patient's Name:	**HIND SAYED ABDEL AZIZ**
Date:	**2026-04-04**
Referred by:	**Prof.Dr. CAP+C**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Opinion:

- **D10 vertebral body sclerotic area and left iliac bone tiny lytic focus are seen for bone scan.**

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

Patient's Name:	**HIND SAYED ABDEL AZIZ**
Date:	**2026-04-04**
Referred by:	**Prof.Dr. CAP+C**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA with no available previous films for comparison.

I- CHEST:

- Left basal atelectatic band.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Gall bladder shows a 21 mm stone.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the rest of pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- D10 vertebral body predominantly sclerotic area is noted.
- Tiny left iliac bone lytic focus is seen.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر
Children's Cancer Hospital Foundation - Egypt
57357

Nuclear Medicine Dept.
PET/CT Unit

Name: Hend Sayed Abd El-Aziz. Date: 15.6.2025 .
Referred by Prof. DR. Mohammed Hefny. MRN : 30192747.

F18-FDG PET/CT STUDY

CLINICAL HISTORY:

- 42 y-old female patient of breast cancer.

REASON FOR PET/CT STUDY:

- Assessment of response to therapy.

TECHNIQUE:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- Time from 18F-FDG injection to scan:60 min
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: No previous PET CT studies.

1 Fostat street, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745

١ شارع الفسطاط - السيدة زينب - القاهرة
ص. ب : ١ الدواوين - مصر
التليفون: 19057 (202)
فاكس: 1745 35 25 (202)

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر
Children's Cancer Hospital Foundation - Egypt
57357

Nuclear Medicine Dept.
PET/CT Unit

Musculoskeletal:

* D10 shows mixed lytic/sclerotic osseous lesion of SUVmax~3.5.

IMPRESSION:

No definite metabolically active FDG avid gross breast lesions.

FDG avid D10 bone lesion.

Thanks for referral;

Nuclear Medicine Unit;

Dr. Mary Rabea , MD
Radiology consultant

Dr. Maha Mehesen, MD.
Nuclear medicine consultant.

رحلة علم, صدفها الحياه
Knowledge into Action

1 Fostat street, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745
E-mail: info@57357.org
www.57357.org

١ شارع الفسطاط - السيدة زينب - القاهرة
ص. ب : ١ الدواوين - مصر
الهاتف: 19057 (202)
فاكس: 1745 35 25 (202)

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

جوستافوسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 24/12/2025 G

هند سيد عبدالعزيز محمد
DOB: 1982-09-27 Female
MRN: 289/2025

Name	هند سيد عبدالعزيز	MRN	289/2025
		ID	[illegible]
Age	42	Phone	01141118701
Menopausal status	Pre	Marital status	married
NRS SCORE		Family history	
BMI	>30	REASON OF MDT	Surgery.
CO morbidity	-ve		

Clinical Data

BX:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
818	718	+2 amplified by SISH	17%

Sonomammography:
BSM → L+ breast 2 masses
UOQ

Mets Workup: + axillary L-N.
CT CAP → HFLs → Triphasic → benign
D10 lesion → RLF
Started Taxol / Herceptin / Zometa - 24 weeks last 12/11/2025

R L

TNM 3 1 1 D10

Recommendations:
PET/CT 6RS → almost CR
PET/CT 25/11/2025 → CR
Continued Taxol / Herceptin
BSM → Requested
For MDT regarding Surgical Excision if possible and Starting AI / Zoladex

MDT OUTCOME & PLAN
-ve LNs
- Continue Herceptin I-V + Letrozole + Zoladex 3/12/2025.
- as Pt not fit for start as only No LNs NGS BRCA before cancelling
Pt about to Lock Surgery

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
	24/12/2025	24/12/25			

NOT FOR COPYRIGHT PURPOSES